

Cancer de l'œsophage

Diagnostic-traitement

Pathologie chirurgicale

Année universitaire 2016-20167

Dr Mamadou Cissé, Professeur Titulaire , Chirurgie Générale, HALD

Objectifs

- Classer les facteurs de risque du cancer de l'œsophage en fonction du type histologique
- Citer les circonstances de découverte du cancer de l'œsophage en précisant le maître-symptôme et 4 signes de mauvais pronostic
- Décrire les apports du principal examen complémentaire qui permet de faire le diagnostic de cancer de l'œsophage
- Décrire les résultats du transit oeso-gastro-duodénal dans le cancer de l'œsophage
- Citer 5 examens de référence utiles au diagnostic d'extension du cancer de l'œsophage
- Préciser les indications thérapeutiques dans le cancer de l'œsophage en fonction du stade

Généralités

- **Définition:** Prolifération tissulaire secondaire à une division cellulaire anarchique incontrôlée avec tendance à l'essaimage et à la récurrence développée au dépens de l'œsophage
- « néoplasies malignes » développées au dépens de l'œsophage
- **Épidémiologie descriptive**
 - Incidence: 3,9/100 000
 - 15% des cancers digestifs
 - 5% des cancers de l'homme

Généralités

- **Anatomopathologie**

- **Macroscopie**

- Forme ulcéro bourgeonnante en lobe d'oreille est la plus fréquente
 - Formes infiltrante ou ulcérée rares

- **Microscopie**

- 2 principaux types histologiques
 - **Carcinome épidermoïde**
 - 90% des cancers de l'œsophage
 - Siège au 2/3 inférieurs
 - **Adénocarcinome**
 - 10% des cancers de l'œsophage
 - Siège au 1/3 inférieur
 - **Autres:** carcinoïde, mélanome, lymphome, sarcome

Généralités

- **Facteurs de risque**

- **Carcinome épidermoïde**

- **Facteurs exogènes**

- Tabac, alcool: dose-dépendante
 - Carences alimentaires en vitamines A, E et en oligo éléments
 - Irritation thermique: **consommation de boisson très chaude**
 - Nitrosamines
 - Papillomavirus humain
 - Radiothérapie antérieure
 - **Rôle protecteur des fruits et légumes**

Généralités

- **Facteurs de risque**

- **Carcinome épidermoïde**

- **Facteurs prédisposant**

- Achalasie: dégénérescence dans 2 à 7% des cas et siège au 1/3 moyen
 - Lésions caustiques anciennes de l'œsophage
 - Diverticule de Zenker
 - Syndrome de Plummer-Vinson: dysphagie-anémie ferriprive
 - Antécédent de cancer épidermoïde des voies aérodigestives supérieures
 - Maladie cœliaque
 - Kératodermie palmoplantaire héréditaire: risque est de 100% après 65 ans (mutation sur le Chromosome 17q).

Généralités

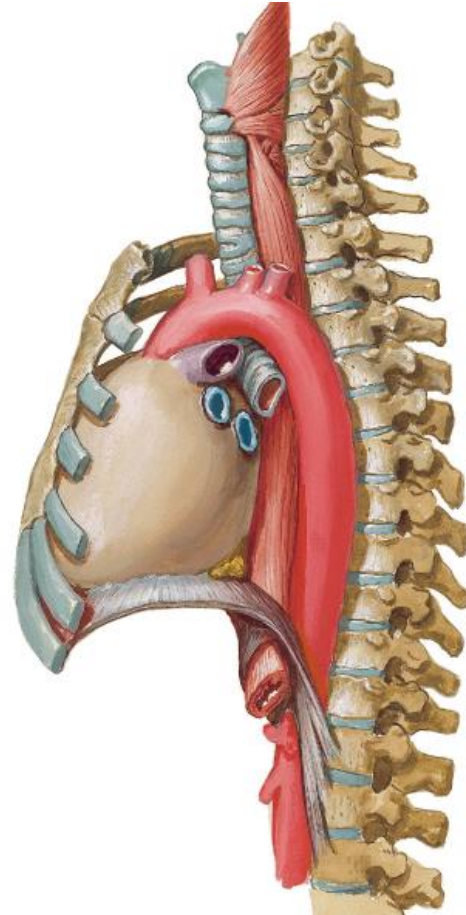
- **Facteurs de risque**

- **Adénocarcinome**

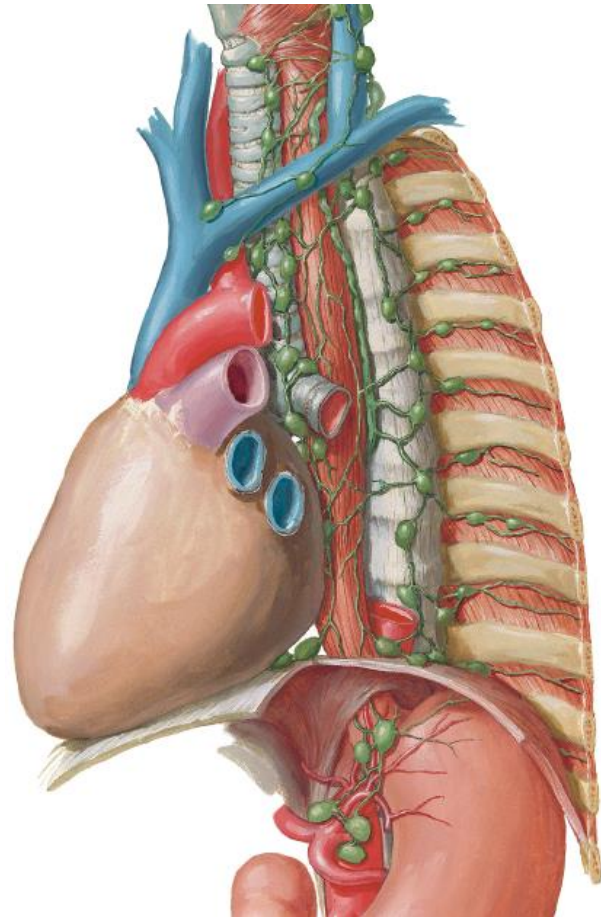
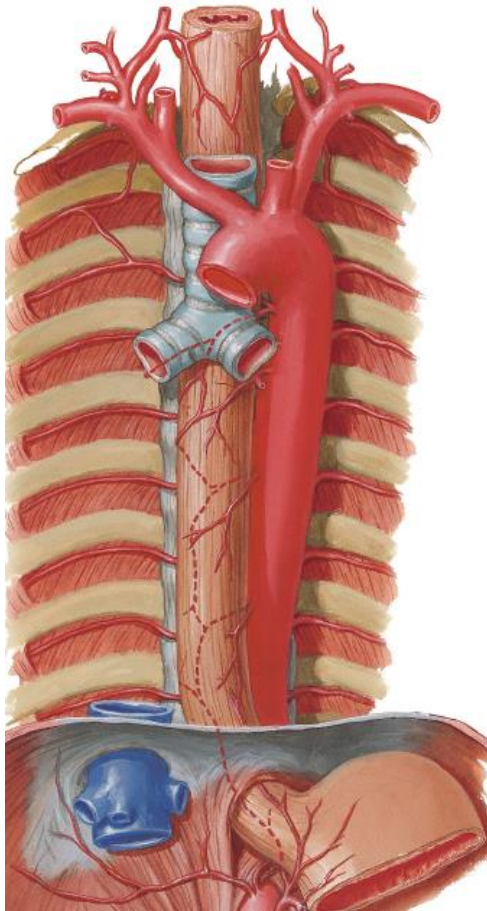
- Tabac
 - Reflux gastro œsophagien
 - **Endobrachyœsophage ou œsophage de Barret:** il s'agit d'une métaplasie acquise où la muqueuse œsophagienne malpighienne est remplacée par une muqueuse glandulaire.
 - Obésité (leptine)

Généralités

- Anatomie
 - L'œsophage est subdivisé en trois segments
 - Œsophage cervical: entre 15cm et 25cm des arcades
 - Œsophage thoracique: entre 25cm et 32cm
 - Œsophage abdominal: entre 32cm et 40cm
 - Trajet médiastinal postérieur



Anatomie



Diagnostic

- **Diagnostic positif**

- **Circonstances de découverte**

- 50 % des cancers sont asymptomatiques.

- **Stade de début**

- gêne alimentaire
 - une douleur rétro sternale à la déglutition

- **Stade plus évolué**

- **Dysphagie: maitre symptôme**, mécanique, d'aggravation progressive
 - Signes associés: odynophagie, douleurs thoraciques, hémorragie, amaigrissement, éructations, hypersialorrhée

Diagnostic

©Signes de mauvais pronostic

- amaigrissement important (plus de 10 % du poids du corps)
- douleurs dorsales d'apparition récente
- dysphonie
- toux à chaque déglutition (signe de fistule oeso-trachéale).
- **Examen clinique**
 - Pauvre
 - Altération état général
 - Recherche localisation secondaire: hépatomégalie, ascite, ganglion de Troisier, ...

Diagnostic

Diagnostic positif



- Paraclinique
 - **Endoscopie digestive haute:** examen de référence
 - Montre la tumeur
 - Précise aspect macroscopique
 - Apprécie l'extension tumorale
 - Précise la distance de la tumeur par rapport aux arcades dentaires. La distance entre les arcades et la bouche œsophagienne est de 15 cm.
 - Coloration au Lugol ou au bleu de Toluidine pour détecter les formes de début et les limites tumorales
 - Colorations électroniques (Hi-scan, ...)
 - Biopsies multiples+++ (au moins 6 à 8) : diagnostic histologique de certitude

Diagnostic d'extension

- **Examen clinique complet dont ORL**
- **Transit œsogastroduodénal**
 - Siège et longueur de la tumeur
 - Apprécie désaxation de l'œsophage
 - Fistule oesotrachéale
 - Aspect de l'estomac (utile pour la gastroplastie)
- **Résultats:**
 - sténose longue, irrégulière, excentrée, angulée et tortueuse
 - ou lacune marginale irrégulière et rigide
 - Au début: sur élévation muqueuse, rigidité localisée, ulcération superficielle



Diagnostic d'extension

- **Tomodensitométrie thoracoabdominale**

- métastases viscérales et ganglionnaires
- envahissement trachéo-bronchique, aortique, péricardique, pleural, pulmonaire...

Critères d'envahissement médiastinal: perte du liséré graisseux
angle supérieur à 90° entre la tumeur et l'aorte

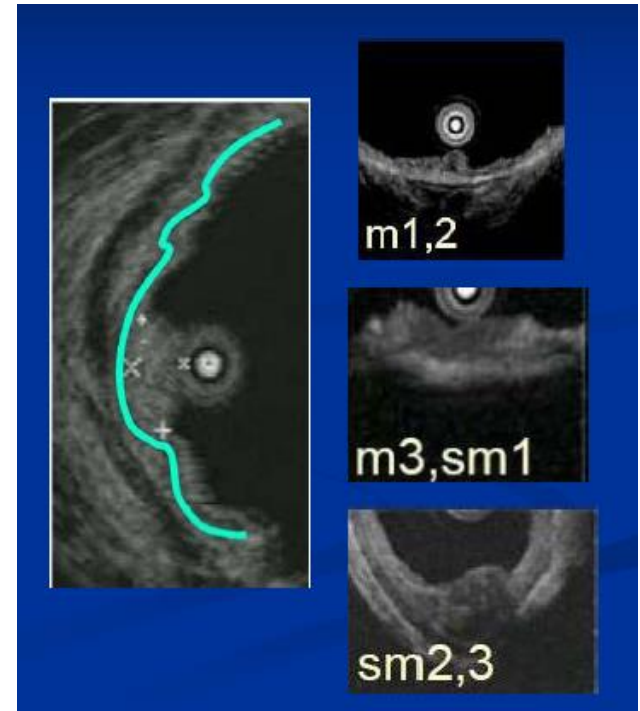


- **Fibroscopie trachéo bronchique**

- Recherche localisation trachéo bronchique

Diagnostic d'extension

- **Echo endoscopie**
 - Extension pariétale de la tumeur
 - Extension ganglionnaire
- **Échographie abdominale**
 - Métastases hépatiques
 - Ganglions coeliaques
- **Échographie cervicale ou sus claviculaire**
 - Ganglions
- **PET-SCANN** (tomographie par émission de positons)



Diagnostic d'extension

- **Examens de première intention**

- **Référence**

- Examen Clinique complet (ganglions cervicaux et sus claviculaires+++)
- Evaluation de l'état nutritionnel (IMC, indice de Buzby)
- Scanner thoraco-abdomino-pelvien
- Examen ORL avec laryngoscopie indirecte
- Fibroscopie trachéo-bronchique

- **En option**

- Écho endoscopie
- Transit œsogastroduodéal
- Échographie sus claviculaire
- Tomographie à émission de positrons (TEP)

Classification us T N M

- **uT1** : tumeur envahissant la muqueuse et la sous-muqueuse
 - **uT2** : tumeur envahissant la musculuse sans la dépasser
 - **uT3** : tumeur envahissant l'adventice (ou la séreuse)
 - **uT4** : tumeur envahissant les structures adjacentes
-
- **uN0** : pas d'invasion ganglionnaire
 - **uN1** : ganglions envahis péritumoraux
 - **uN2** : ganglions envahis à distance de la tumeur

Diagnostic d'extension

Classification pTNM

- **T : tumeur primitive :**
 - Tis : cancer in situ
 - T1 : infiltration de la muqueuse ou de la sous muqueuse
 - T2 : infiltration de la musculuse
 - T3 : infiltration de l'adventice
 - T4 : infiltration des organes de voisinage
- **N : adénopathies régionales**
 - N0 : pas de ganglion envahi
 - N1 : 1 à 2 gg envahis
 - N2: 3 à 6 gg envahis
 - N3: >7 gg envahis
- **M : métastases**
 - M0 : pas de métastases
 - M1 : Présence de métastases

Classification par stade

- **Stade 0:** Tis N0 M0
- **Stade I:** T1 N0 M0
- **Stade IIA:** T2, T3 N0 M0
- **Stade IIB:** T1, T2 N1 M0
- **Stade III:** T3 N1 M0
T4 tout N M0
- **Stade IV:** tout T tout N M1

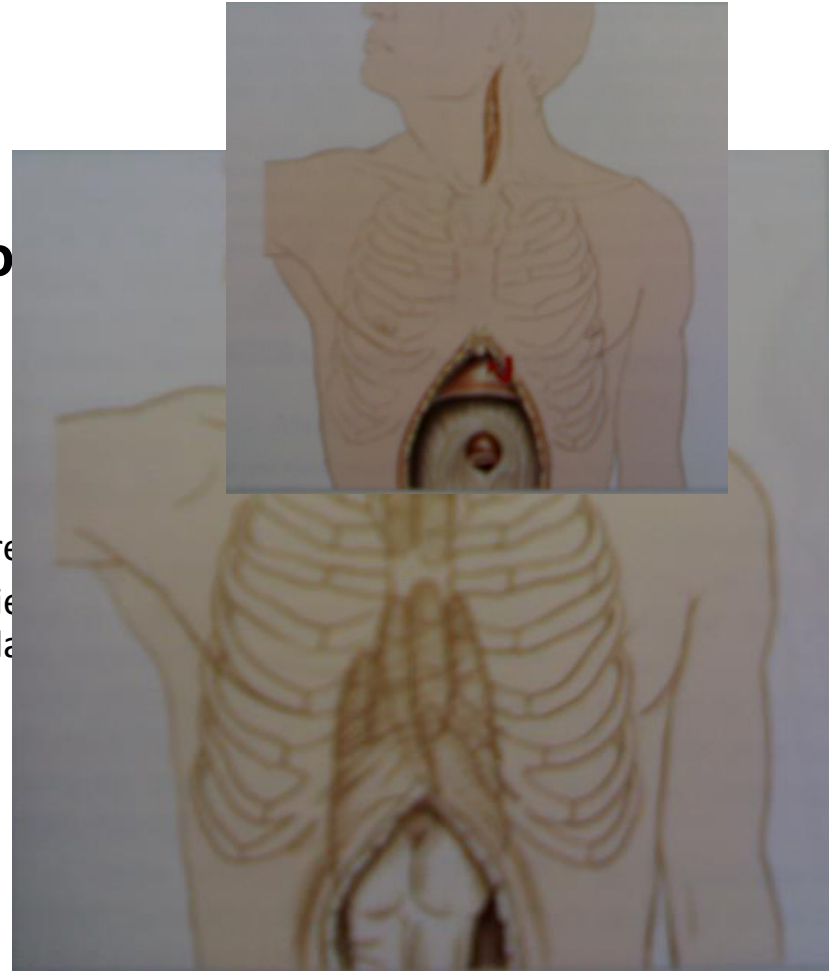
Traitement

- Buts
 - Guérir la maladie
 - Améliorer la survie
 - Éviter et traiter les complications
- Moyens
 - **Chirurgicaux curatifs: principes**
 - résection plus ou moins étendue de l'œsophage en fonction du siège de la tumeur
 - curage ganglionnaire (23 ganglions au moins)
 - 2 groupes d'intervention:
 - **Œsophagectomie sans thoracotomie** (oesophagectomie trans hiatale)
 - **Œsophagectomie avec thoracotomie** (Lewis-Santy, Akiyama, Mac Keown)
 - Le remplacement de l'œsophage réséqué peut se faire en utilisant l'estomac (gastroplastie) ou le côlon (coloplastie)

Moyens chirurgicaux curatifs

Œsophagectomie sans thoraco

- **Œsophagectomie trans hiatale**
 - double voie abdominale et cervicale
 - dissection manuelle thoracique
 - anastomose œsogastrique cervicale
 - minimise le retentissement respiratoire
 - curage des ganglions latéro-œsophagiques, bronchiques, et des ligaments triangulaires

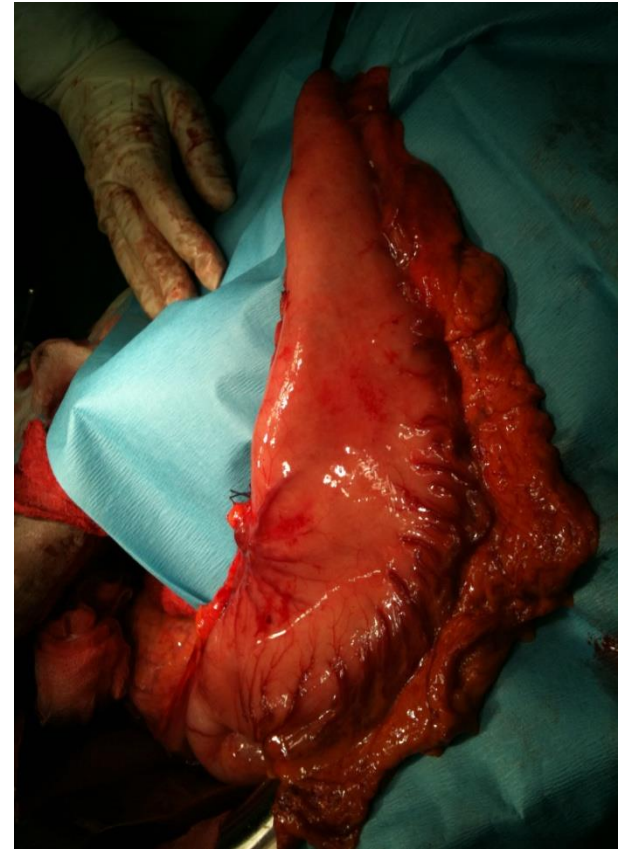


Moyens chirurgicaux curatifs

- **Œsophagectomie avec thoracotomie**

- Intervention de **Lewis Santy**: double voie abdominale et thoracique avec anastomose œsogastrique intra thoracique
- Intervention de **Akiyama ou celle de Mac Keown**: triple abord abdominal, cervical et thoracique

Gastroplastie



Traitement

- **Moyens palliatifs pour la nutrition**

- Gastrostomie d'alimentation
- Jéjunostomie d'alimentation
- Dilatation endoscopique
- Prothèse œsophagienne
- Laser

- **Chimiothérapie:**

- 5 FU-CISPLATINE, LV5FU2-CISPLATINE
- La chimiothérapie post opératoire n'améliore pas la survie

- **Radiothérapie:** curiethérapie, radiothérapie externe

- La radiothérapie isolée n'améliore pas la survie

Traitement

Indications

- **Bilan d'opérabilité**
 - État nutritionnel (% amaigrissement, protidémie, albuminémie)
 - Examen respiratoire (EFR)
 - Examen cardiovasculaire (ECG, échocardiographie)
 - Bilan hépatique
 - Classification OMS de l'état général
 - Sevrage alcool-tabagique

Critères de non opérabilité

- Cirrhose (CHILD>A)
- Insuffisance hépatocellulaire et/ou HTP
- Insuffisance respiratoire: VEMS< 1 000 ml/s
- Perte de poids supérieure à 20 % du poids de forme
- Insuffisance cardiaque stade III ou IV de la NYHA

Indications

- **Cancers opérables: (adénocarcinomes ou épidermoïdes)**
 - **Stade I (T1N0MO):** chirurgie
 - **Stade IIa (T2-T3N0):** 2 options
 - Chirurgie seule
 - Chimiothérapie néo adjuvante puis chirurgie
 - **Stade IIb (T1-T2N1):** 2 options
 - Chimiothérapie néoadjuvante puis chirurgie
 - Radio-chimiothérapie puis chirurgie

Indications

- **Stade III (T3-N1 ou T4-N0-1): 3 options**
 - Chimiothérapie néo adjuvante puis chirurgie
 - Radio chimiothérapie néo adjuvante puis chirurgie
 - Radio chimiothérapie seule

Indications

- **Malades résécables non opérables**
 - Radio chimiothérapie concomitante exclusive
- **Tumeurs localement avancées**
 - Traitement palliatif
- **Fistule œso-trachéale**
 - Prothèse œsophagienne

Résultats

- Résection complète: survie globale à 5 ans: 35 à 41% et dépend de l'extension T et N
- Récidive:
 - Après chirurgie à visée curative: 50% à 12 mois
 - Principaux sièges de récurrence: médiastinal et hépatique

Conclusion

- Cancer sévère du tube digestif
- Endoscopie digestive haute pose le diagnostic
- Scanner et écho endoscopie: extension et résécabilité
- Chirurgie: traitement à visée curative
- Survie à 5 ans faible.